פציעות חודרות בטראומה

שלומית אטלו

ראש צוות טראומה

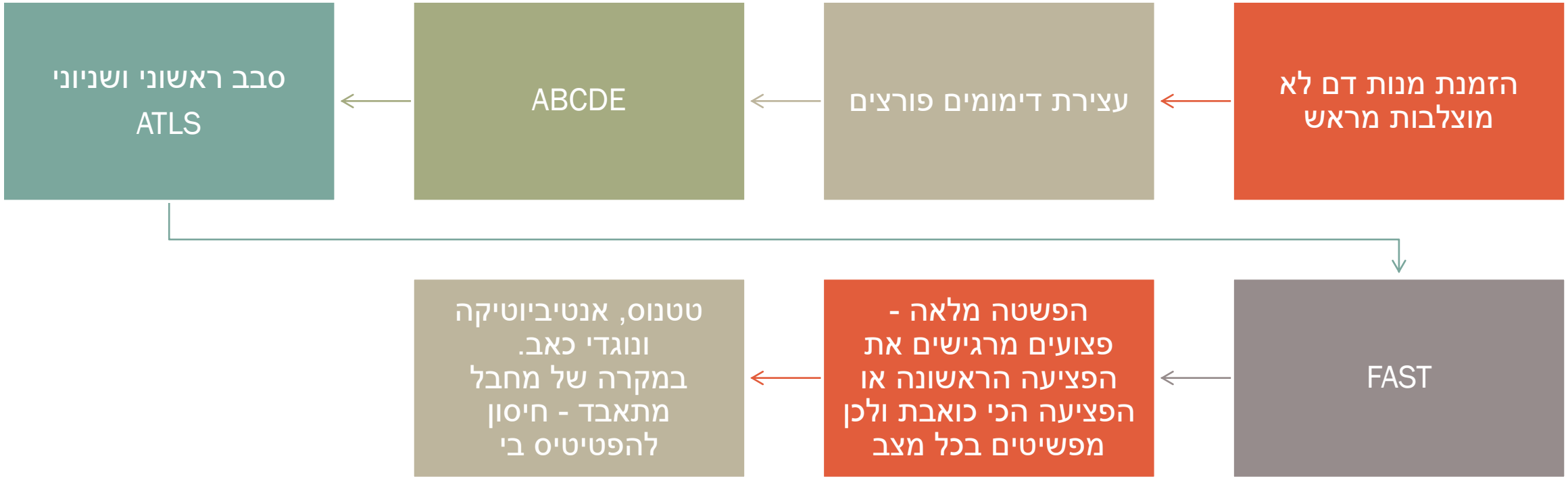
פגיעה חודרת

- הגדרה: פגיעה ממקור חיצוני הפוגעת בשלמות רקמות העור.

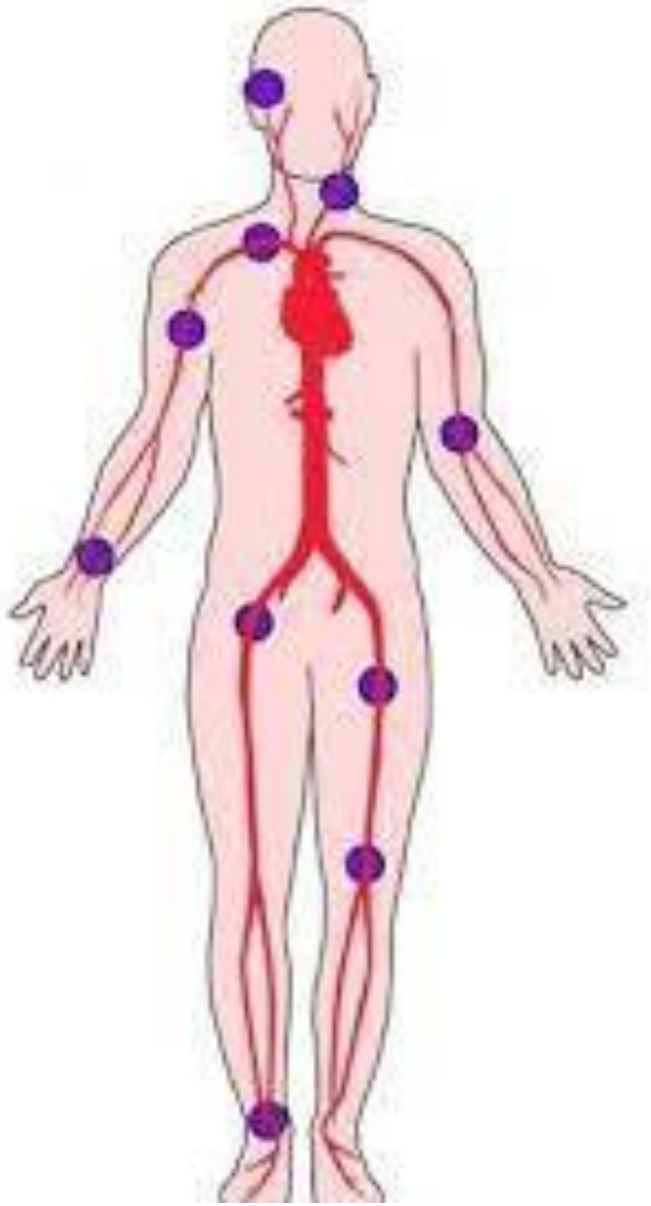
<u>סוגי הפציעות בטראומה:</u>

- אנרגיה גבוהה (ירי, רסיסים)
- אנרגיה נמוכה (דקירה)

קבלה וטיפול בפצוע



עצירת דימומים פורצים



- לחץ ישיר – לחיצה על הפציעה המדממת עם תחבושת
- לחץ עקיף – נקודות לחיצה להפסקת דימום (עם היד) כפי שמוצג בתמונה
- חוסם עורקים – כ 5 ס"מ מעל הפציעה עם חסם עורקים / טורניקט, לטפל בדימום ובמידת היכולת להוריד את החוסם.
  - פצוע שהגיע עם חוסם עורקים יש לשאוף להורידו בהקדם האפשרי אך בצורה מבוקרת (במידה והחוסם מונח מספר שעות יש לתת טיפול תרופתי מקדים למניעת הפרעות קרדיאליות ונפרולוגיות)
- קטטר שתן לפצע כניסה – הבלונית מייצרת לחץ מקומי, בעיקר באיברים שלא ניתן להניח עליהם חוסם עורקים (טורסו, צוואר, ראש הירך) .

סרטון הסבר: https://youtu.be/BpqRIhhrkUM?si=-WVX3juLOeyT5XCI

פציעת ירי

הבדל בין סוגי הנשקים ואנרגית הפגיעה (ביחס לפצעי ירי):

- אנרגיה נמוכה – אקדחים בדר"כ. הנזק ממוקד למסלול הקליע
- אנרגיה גבוהה – בדר"כ רובי ציידים / צלפים. מיצר פגיעה משמעותית בחורי כניסה ויציאה וכן נזק רוחבי בנתיב הקליע

- יש לחפש פצע יציאה / כניסה
- יש לשים לב למסלול הקליע (במקרה של פצע יציאה) ולצפות פגיעה בכל איבר העומד בדרך
- לקראת הסיטי יש לסמן עם סיכות (בעגלת פתיחת חזה) כל פצע כניסה / יציאה בכדי לזהות את מסלול הקליע בסי-טי

רסיסים

- פציעות רסיסים מפיצוצים / חלקי קליעים בדר"כ מפושטים לאזורים רבים בגוף ובעלי מסלולי פגיעה שונים
- פצעי הכניסה יכולים 'להתחבא' במקומות רבים, יש להקפיד על הפשטה ואיתור מקומות רגישים למגע ולחפש חורי כניסה (בעיקר באזורים שעירים)
- CT כלל גופי לאיתור רסיסים
- בדיקת עיניים גם במצב שאין תלונות, למדנו במלחמה כי ישנם פגיעות מסכנות ראייה גם ללא תלונות

דקירה

- חשוב לחפש פצעי דקירה נוספים מעבר לאזור שהמטופל מתלונן עליו או שדווח עליו
- לא! להוציא את הסכין במידה והוא עדיין בפנים, לאחר הדמיה והבנת מבנה הסכין ואיברים הפגועים ניתן (ע"י רופא בלבד)
- יש לסמן את הפצע בסיכה לקראת ביצוע הסיטי (במידה והסכין לא בגוף)

דגשים לפי אזורי פגיעה

- ראש – בראש כלי דם רבים (וקטנים) וכן יכול להיות דימום מוגבר מפציעות שטחיות.
ובמקרה של יציאת רקמת המוח החוצה יש לשפוך סליין סטרילי ולכסות.
- צוואר – סיכון גבוה לפגיעה ורידית / עורקית ופגיעה בנתיב אוויר. חשוב להזמין רופא אא"ג מראש.
- בטן – בבטן איברים מרובים, איברים חלולים וכן איברים מלאים בדם. בנוסף ישנם כלי דם גדולים מאוד במרכז הבטן.
סיכון לדימום משמעותי ו/או יציאת תוכן מעי לבטן.
- גפיים – סיכון לדימום, שברים בעצמות גדולות, פגיעה עצבית ופגיעה ברקמות רכות. יש לשים לב לחשד לתסמונת מדור עקב דימום פנימי ברקמת השריר.
מומלץ לקרוא לרופא כלי דם להערכת המטופל בקבלתו

פגיעה חודרת בחזה

- ריאות - סיכון לחזה דם / חזה אוויר, טיפול ע"י הכנסת נקז חזה במידת הצורך.
  במטופל עם חזה אוויר בלחץ יש לשקול הכנסת מחט לחזה (NA) טרם הכנסת הנקז לצורך ייצוב המודינמי מהיר.
- צלעות – פגיעה יכולה להביא לכאבים המחמירים בנשימה, יש לתת דגש על מתן משככי כאבים ומעקב נשימתי.
- כלי דם גדולים – סיכון לדימום משמעותי, יש לתת דם בהקדם ובמידת הצורך הפעלת פרוטוקול מתן דם מאסיבי (MTP)
- לב – סיכון לקרע ברקמת הלב / טמפונדה.
  במטופל לא יציב יש לבצע פתיחת חזה (Thoracotomy) למצוא את האזור הפגוע ולתפור

❖ במקרה של פתיחת חזה (מטופל לא יציב) יש לעדכן במיידית אחראית משמרת (!), לקרוא לצוות חדר ניתוח ולהפעיל פרוטוקול מתן דם מאסיבי.
מטרת פתיחת בית חזה היא לחסום את האורטה היורדת בכדי 'לחסוך' דם על איברי הגוף פרט לריאות, לב ומוח ובמידת הצורך לתפור את רקמת הלב הפגועה.
(מצגת על פתיחת בית תופץ בהמשך)

בהצלחה
ונקווה לימים שקטים
ורגועים!